11. 心臓：要約と実践的示唆

所要時間：11:02 学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における心臓の重要性を探り、心臓を精子と卵子の間の生命力の出会いの場として位置付けています。心臓が原始線条内でどのように形成され、神経管や中胚葉などの主要な構造とどのように相互作用するかが説明されています。拡張期と収縮期の概念も取り上げられ、これらの動きがオステオパシーの診療でどのように観察され、統合されるかに特に注意が払われています。施術者は、胚性支点を使用して心臓と脳のシステムを活性化し、バランスを取る方法を学び、関連する支点を通じてアプローチを洗練させます。

心臓：要約と実践的示唆

心臓：象徴的な出会いの場

心臓は、**精子**と**卵子**の象徴的な出会いの場と見なされています。ここで**基本的なパターン**が確立され、極性という平面でも現れます。



図 — 2細胞胚

出現と初期発達

心臓の出現は、**原始線条**のレベルで特に興味深いものです。

それはS2の下、**脊索**の末端であり、感覚の場所の痕跡です。

私たちは、その顔面環境と発達運動においてそれにアプローチします。それは、閉鎖と小骨盤の配置の際に**二次神経管形成**に再統合されます。

二次神経管形成は、**終糸**と**尾芽**の間の空間であり、**神経管**の**前内胚葉**に対する分化成長を伴い、内腔が開きます。

前内胚葉は胚の内胚葉ですが、ここでは**中胚葉**レベル、そして心臓レベルでもあります。

S2で終わる原始線条を伴うこの波の中には、すでに**原始心臓力**が存在します。上胚葉における推定される位置は、心臓の可能性の一部であり、特定された最も初期の位置です。

心臓形成細胞は、中胚葉形成前の上胚葉の推定層にあります。

この推定層を再び見つけます。成長運動の後にうっ血が続き、その後、**羊膜腔**によって周辺から組織化された2つの管の統合と出会いが起こります。神経管、心臓管、そして横隔膜の統合が心臓の配置に貢献します。

これは、神経管の閉鎖と、外部の**体腔**が内部の体腔に統合されるのと同時に起こります。

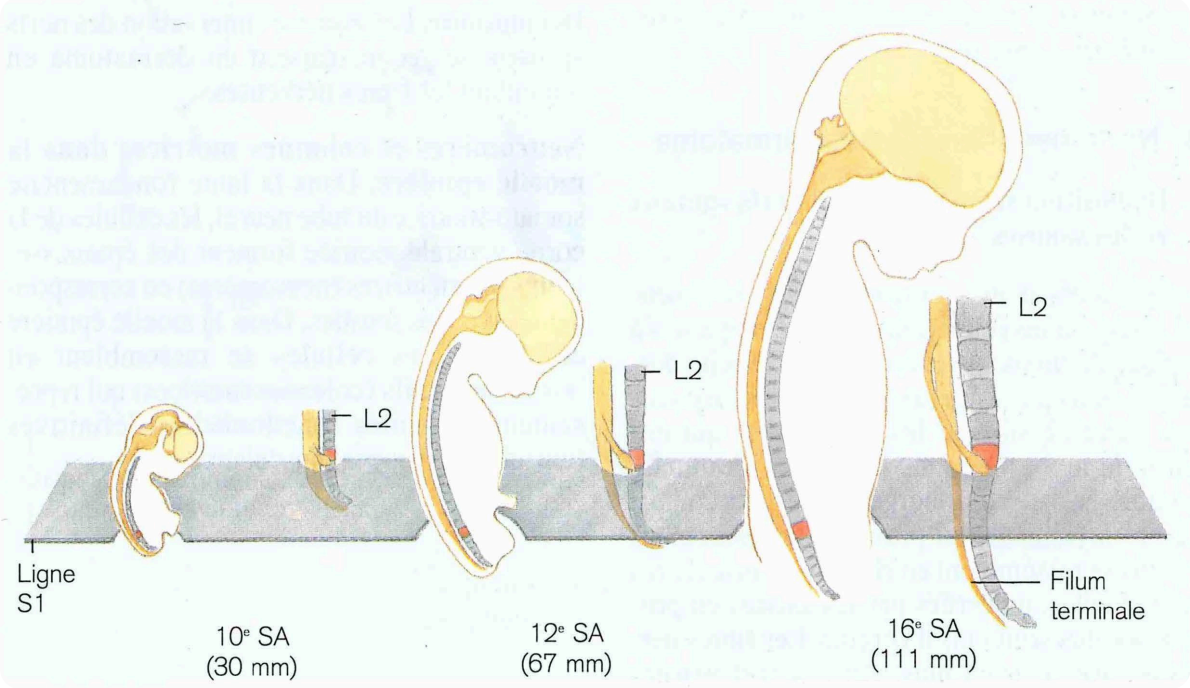


図 — 脊髄の相対的成長

原始線条と心臓の支点

特定可能な最も初期の場所は原始線条です。

脊索はS2のレベルで終わります。S2と原始線条の末端の間の空間には、原始線条の痕跡が含まれています。

心臓の**胚性支点**は尾骨にあります。

心臓は、エネルギーと容積を求めて、むしろ**拡張期**の姿勢になります。その動きの中で下降します。

心臓もまた、支点、つまり起源点を持っており、それを異なる形で示すことができます。

心臓の動きと構造

脳と**頭部形成**、そして心臓と**心臓形成**の間で動きが確立され、それらの出会いを可能にします。

同時に、2つの心内膜管が正中線上で出会います。続いて心臓の**ルーピング**、そして**心臓洞**と**大動脈弓**、および大血管の配置が起こります。

大静脈軸が目印となります。

心臓が収縮期または拡張期の平面で表現されているかどうかを観察することが重要です。顔面では、拡張期または収縮期をより求めています。

腸骨に対して、それははるかに**水平性**を求めており、これは拡張期運動を示しています。**大動脈拍動**を探すことさえできます。

脳と心臓の発達

私たちは、発達運動に対する脳の発達を徐々に統合していきます。

脳の最初の発達運動は**拡張**でした。この拡張は**縦軸**または**腸間膜軸**に依存していました。それは卵黄の統合に依存しており、その痕跡は腸間膜軸に見られます。

次に、栄養にとって重要なもう1つのレベルは、**脾臓**と**肝臓**の間のシステムであり、**大静脈**を介して心臓に戻ります。その後、大動脈の情報は、頸動脈、上、下、椎骨という4つまたは2つの入り口によって現れます。

このようにして、脳の発達を心臓と腸間膜系と統合します。脳に働きかけることで、どの領域を開くべきかを観察します。心臓に対する頸動脈系など、働きかけるべき領域を特定するために知覚を洗練させることができます。

これは、胚性支点であろうと、再生力を再活性化するための構築における支持点であろうと、単純な支持点を与えることによって行うことができます。

支点は出現点です。**卵黄嚢**が動脈に統合されるような発達の力全体（発達経路の痕跡であり、胚性支点ではない）は、支点と最終目標の間に位置します。

私たちは、特定の動脈に働きかけることになるので、これから取り組むゲームを認識し始めています。目標は、**完全なホメオスタシス**、完全な活力、完全な健康を取り戻すことです。

支点の起源と中胚葉の波

私はその支点の起源に触れます。それは尾骨レベルで間接的に見られ、その後、**マノトコッカス**の発達運動、つまり中胚葉レベルでの吸引を伴うこの波によって、徐々にそのシステムに統合されます。

これは、組織を再構築し、再活性化し、力を与え、機能を取り戻す情報です。

胚性力の発展は、システムの主要な機能の発展を可能にします。

横隔膜の中心的な役割

これらすべてにおいて、偉大なマスターは**横隔膜**です。この横隔膜に3つのレベルで適切に位置することが重要です。

- 横方向の**羊膜腔**
- **胸部**
- **腹部**

この体腔の統合、そして同時に脳、心臓、横隔膜、腹膜の後部の統合は、**会陰**に戻り、肝臓のこの傾きによって、**尿生殖器系**のすべての情報を提供する私の白線のすべての閉鎖を再構築します。

白線と尿生殖器系

このようにして形成されます。**白線**は、尿生殖器系の完全な統合を表しており、それがその最終的な歴史です。

この白線上には、結晶化した時間の集中を見つけることができます。なぜなら、それは**赤血球**、血球の形成、つまり未来に関連する確率の線であり、**交接器**の平面もあなたの未来だからです。

出生時、伸展が起こり、このようにして、すべての外部および内部生殖器系がこの前白線の平面に統合されます。それは再構築するために終わります。

血球の平面では、**赤血球増加症**または**生殖細胞増加症**が進行します。ある時点で、胚は動きます。人生には開始線があります。誕生の瞬間、この線、白線を開き、人生を開始する必要があります。

胚性支点と動脈系

考えられるのは、適切な**胚性支点**を取り戻すことです。動脈系は**タコ**のように見なされるべきです。

明日、顔面レベルの動脈系を詳しく説明します。なぜなら、それは脳への栄養アクセスポイントだからです。頸動脈系と椎骨系の発達を理解する必要があります。

これらの2つのシステムは、**ウィリス動脈輪**と前、中、後**脳動脈**、および静脈洞または弁（ブレシェットの弁、ティエリー・ゴイディエンヌの弁など）に関するすべての情報とともに、平衡の空間です。

脳血管の平衡

血管供給と静脈還流の間に平衡が必要です。現在、脳には**リンパ系**が存在することが知られています。

余分なものを排除するために、一部の人々は脳レベルで**リンパうっ血**または静脈うっ血を抱えている可能性があります。これは、少し腫れている、少し浮腫のある人々に見られます。還流が起こっていません。

したがって、**上大静脈**または下大静脈のレベルで、静脈平面の再平衡化作業が必要です。これは、特に耳のうっ血や排出できないものすべてを避けるために重要です。

治療姿勢

私は尾骨と心臓のレベルにしっかりと位置しています。**ルイ角**、大動脈肺型の血管幹を視覚化できます。

心臓は**縦軸**上にあります。その一部だけが左に拡張しており、心臓の先端が左に発達する段階があります。

心臓の縦平面に位置します。ここに支点を与え、心臓に支持点を与えることで、私の注意は空間にあり、中立であり、システムが自己組織化するに任せます。